

EPICRISIS
Nº192562

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha Documento: 29/noviembre/2025 04:58 p. m. **Ingreso:** 352050 **Confirmad**
Médico: 1140887548 NELLYS LEONOR PINEDA ESPITIA
Informacion Paciente: GUADALUPE PERALTA SABALLET **Tipo Paciente:** Contributivo **Sexo:** Femenino
Tipo Documento: Tarjeta_de_Identidad **Número:** 1066292466 **Edad:** 11 Años / 10 Meses / 14 Días **F. Nacimiento:** 14/01/2014
E.P.S: STP002 **SAUD TOTAL EPS-S - PG HOSPITALARIO**
Entidad:

INFORMACIÓN DE LA EPICRISIS

Servicio de ingreso: Urgencias **Fecha Ingreso:** 29/noviembre/2025 10:49 a. m.
Servicio de Egreso: Ninguna **Fecha Egreso:** 29/noviembre/2025 04:58 **Estado Paciente:** VIVO p. m.

Motivo Consulta:

" NO SE SIENTE BIEN "

Enfermedad Actual:

PACIENTE FEMENINA DE 11 AÑOS DE EDAD, QUIEN INGRESA AL SERVICIO DE URGENCIAS EN COMPAÑÍA DE SU PADRE, POR PRESENTAR CUADRO CLÍNICO DE APROXIMADAMENTE 2 DÍAS DE EVOLUCIÓN. SEGÚN REFIEREN LOS PADRES, LA PACIENTE PRESENTÓ UN INTENTO DE AUTOLISIS EL DÍA JUEVES 27/11/2025, RELATANDO QUE LA MENOR SE ENCONTRABA COMO EN UNA CRISIS DE ANSIEDAD. INDICAN QUE LA PSICÓLOGA DEL COLEGIO LA ENCONTRÓ LLORANDO Y QUE POSTERIORMENTE SE IDENTIFICARON VARIAS CARTAS ESCRITAS POR LA MENOR DIRIGIDAS A SUS AMIGOS, EN LAS QUE MANIFESTABA IDEACIÓN AUTOLESIVA. LOS PADRES REFIEREN QUE FUERON CITADOS POR EL COLEGIO PARA INFORMARLES SOBRE LA SITUACIÓN Y EL CONTENIDO DE LAS CARTAS. LA PACIENTE TAMBIÉN RECONOCE HABER ESCRITO CARTAS DE DESPEDIDA DIRIGIDAS A SUS PADRES. MANIFIESTA QUE NO ENTIENDE DEL TODO EL MOTIVO POR EL CUAL ESCRIBIÓ DICHAS CARTAS, PERO REFIERE SENTIMIENTOS RECURRENTES DE DESÁNIMO Y FALTA DE SENTIDO EN SU VIDA. LA MADRE COMENT. QUE, EN DÍAS PREVIOS, DURANTE UNA CLASE LA MENOR REPORTÓ NO HABER ENTENDIDO UN TEMA, MOMENTO EN EL QUE EL PROFESOR INTENTÓ EXPLICAR NUEVAMENTE. SIN EMBARGO, REFIEREN QUE DE MANERA REPENTINA LA PACIENTE MANIFESTÓ "HABER ESCUCHADO VOCES". LA MADRE INFORMA ADEMÁS QUE LA MENOR, POR LO GENERAL, ES AMOROSA, PERO QUE ÚLTIMAMENTE HA PRESENTADO CAMBIOS EN SU COMPORTAMIENTO, MOSTRÁNDOSE DESANIMADA Y DISTRAÍDA. EL PADRE REFIERE QUE EN OCASIONES LE PIDEN FAVORES SENCILLOS, COMO TRAER ALGUN OBJETO, Y LA MENOR DA UNOS PASOS Y OLVIDA LO QUE LE SOLICITARON. AMBOS PADRES MANIFIESTAN QUE LA PACIENTE ES MUY AUTOEXIGENTE Y SOSPECHAN QUE LAS EXPECTATIVAS QUE ELLA MISMA SE IMPONE, SUMADO AL HECHO DE NO LOGRAR LOS RESULTADOS QUE DESEA, PODRÍAN ESTAR GENERANDO FRUSTRACIÓN Y CONTRIBUYENDO A SU ESTADO EMOCIONAL.

ANTECEDENTES

PATOLOGICOS:

QUIRURGICOS: CRANEOCINOSTOSIS

FARMACOLOGICOS: MADRE NIEGA

ALERGICOS: MADRE NIEGA

HOSPITALIZACIONES: HOSPITALIZADA EN EL SEPTIEMBRE (23-09-2025)

FAMILIA: FUNCIONAL

TRAUMATICAS: MADRE NIEGA

TRANSFUSIONALES: 2 PINTAS

FAMILIARES: MADRE NIEGA

HEMOCLASIFICACION: O RH +

VACUNAS: INCOMPLETAS PARA LA EDAD

NEURODESARROLLO: DESARROLLO PRECOZ

Revisión del Sistema:

LO REFERIDO EN HISTORIA CLÍNICA.

Indica Med/Conducta:

Estado Ingreso:

Antecedentes:

Nombre reporte: HCRPEpicrisis

Pagina1/5

Usuario: N.PINEDA

LICENCIADO A: [UNIDAD PEDIATRICA SIMON BOLIVAR - IPS SAS] NIT [900601052-7]

Tipo:Médicos Fecha: 24/09/2025 04:34 p. m.
Detalle: OBESIDAD
Tipo:Médicos Fecha: 25/09/2025 01:35 p. m.
Detalle: OBESIDAD

Result. Procedimientos:

Condiciones Salida:

ESTABLE

Indicación Paciente:

PLAN:
MANEJO PRIORITARIO CON EQUIPO DE SALUD MENTAL, MANEJO AMBULATORIO REFORZADO Y PRIORITARIO CON PSIQUIATRIA Y PSICOLOGIA (CONTROL EN DIAS) CONSULTA EXTERNA.
SE ORDENA ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE (24 HORAS) POR FAMILIARES EN SU DOMICILIO Y ENTORNO ESTUDIANTIL.
SE DAN RECOMENDACIONES Y PAUTAS DE ALARMA

MEDICACION:

- RISPERIDONA TAB 1MG VO (0-0-1)
- FLUOXETINA JARABE 20MG/5ML VO (INICIALMENTE 2.5ML POR LAS MAÑANAS POR UNA SEMANA Y LUEGO 5ML POR LAS MAÑANAS).

Examen Físico:

Cabeza y Cuello:
CONJUNTIVAS NORMOCRÓMICAS, MUCOSAS HÚMEDAS, CUELLO SIN ADENOPATÍAS, OTOSCOPIA NORMAL, RINOSCOPIA NORMAL, AMÍGDALAS NORMALES
Torax:
SIMÉTRICO, RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS CON MURMULLO VESICULAR CONSERVADO, SIN AGREGADOS PULMONARES
NO SIGNOS DE DISTRES RESPIRATORIO
Genito-Urinario:
NORMOCONFIGURADO
Extremidades:
EUTRÓFICAS, SIN EDEMAS, CON LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEG Y ARCOS DE MOVIMIENTO CONSERVADO
Neurológico:
ALERTA, ORIENTADO EN TRES ESFERAS, PUPILAS NORMOREACTIVAS, NO PRESENTA SIGNOS DE FOCALIZACIÓN, FUERZA MUSCULAR +++/++++ Y REFLEJOS
OSTEOTENDINOSOS +++/++++
Tensión Arterial Sistólica:
119
Saturación de Oxígeno:
98
Tensión Arterial Diastólica:
59
Tensión Arterial Media:
79
Frecuencia Cardíaca:
80
Frecuencia Respiratoria:
19
Temperatura:
36,0000
Talla:
156,0000
Índice de Masa Corporal:
29,42
Peso:
71,6000
Abdomen:
DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, SIN MASAS NI MEGALIAS, NO PRESENTA SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL
Perfusión:
< 2
Estado de Conciencia:
Alerta
Piel:
SIN LESIONES

Justificación:

Resultado Examen:

Justificación Muerte:

DIAGNÓSTICOS

TIPO DIAGNÓSTICO	CÓDIGO	NOMBRE	HC
Ingreso/Relacionado	F323	EPISODIO DEPRESIVO GRAVE CON SINTOMAS PSICOTICOS	☒
Egreso	F413	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD MIXTOS	☒
Egreso	F322	EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS	☒
Egreso	R443	ALUCINACIONES, NO ESPECIFICADAS	☒
Egreso	F323	EPISODIO DEPRESIVO GRAVE CON SINTOMAS PSICOTICOS	☒

EVOLUCIONES

FECHA	MÉDICO
29/11/2025 12:06 p. m.	FRAGOZO DAZA VERONICA ISABEL

Analisis:
ACTUALMENTE VALORO A PACIENTE FEMENINA DE 11 AÑOS EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES. TOLERA OXÍGENO AMBIENTE CON SATURACIONES ADECUADAS, PRESENTA BUEN PATRÓN RESPIRATORIO Y SE ENCUENTRA HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, CON RESPUESTA PRESORA Y CRONOTRÓPICA ADECUADA, SIN REQUERIMIENTO DE SOPORTE VASOACTIVO. PACIENTE SE ENCUENTRA TRANQUILA, COLABORADORA Y CON BUENA COMUNICACIÓN, MANIFESTANDO DE MANERA CLARA SUS EMOCIONES, SENSACIONES Y PENSAMIENTOS RECIENTES. DADA LA NATURALEZA DE LOS PENSAMIENTOS EXPRESADOS Y EL RIESGO IDENTIFICADO, SOLICITO DE MANERA URGENTE VALORACIÓN Y MANEJO POR LOS SERVICIOS DE PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA PARA DEFINIR CONDUCTA. SE EXPLICA A LOS PADRES EL MANEJO A SEGUIR, QUIENES MANIFIESTAN ENTENDER LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA.

Plan de Manejo:**PLAN**

PESO: 74,6 KG

OBSERVACION

NO CANALIZAR

SS/ VALORACION POR PSIQUIATRIA

SS/ VALORACION POR PSICOLOGIA

CUIDADOS POR ENFERMERIA

CONTROL DE SIGNOS VITALES.

AVISAR CAMBIOS DESFAVORABLES A MEDICO DE TURNO.

IDX:

- IDEACIÓN SUICIDA ACTIVA EN PACIENTE PEDIÁTRICA.
- TENTATIVA DE AUTOLISIS RECIENTE.
- SÍNTOMAS COMPATIBLES CON TRASTORNO DEPRESIVO EN EVALUACIÓN.
- POSIBLE EPISODIO DE ANSIEDAD CON COMPONENTE DE CRISIS EMOCIONAL.
- REFERENCIA DE ALUCINACIONES AUDITIVAS (POR CONFIRMAR).

29/11/2025 02:59 p. m.	CONTRERAS DUARTE YONNY HUMBERTO
------------------------	---------------------------------

Revaloracion:

PSIQUIATRIA:

PACIENTE EN LA UNIDAD CON FAMILIAR PRESENTE (MADRE). INGRESA POR CUADRO CLINICO CARACTERIZADO POR IDEAS DE MUERTE, CON PLANEAMIENTO AUTOLITICO SIN EJECUCION (LANZARSE DE ALTURA EN EL COLEGIO). COMENTA PACIENTE QUE EL DIA JUEVES (27/11/25), EN EL COLEGIO, PRESENTO CONDUCTA IMPULSIVA ACOMPAÑADO DE CRISIS DE ANSIEDAD, CON RIESGO DE LANZAMIENTO DE ALTURA, DEBIDO A SU EPISODIO DE INESTABILIDAD EMOCIONAL. PREVIO A DICHA SITUACION REALIZO NOTAS DE TEXTO MANIFIESTANDO SU TRISTEZA E INESTABILIDAD EMOCIONAL, CON UN MENSAJE AMBIVALENTE DONDE "SE DESPEDIA DE LAS PERSONAS" PERO A LA VEZ COMENTABA LOS PLANES QUE DESEABA A FUTURO. COMENTA PACIENTE ADEMÁS QUE DIAS PREVIOS A RAIZ DE FRUSTRACION POR MAL RENDIMIENTO ACADEMICO, COMENZO A MADURAR LAS IDEAS NEGATIVAS DE MUERTE Y PLANEAMIENTO, SIN EMBARGO LA MAGNITUD Y CONSECUENCIAS DEL ACTO A LLEVAR A CABO; LA PUSIERON EN UN CONTEXTO DE NO DESEAR LLEVAR A CABO UN EVENTO AUTOLITICO. MANIFIESTA QUE HA VENIDO CON INESTABILIDAD EN SU ESTADO ANIMICO (NO DESCRIBE UNA CAUSA PUNTUAL) PERO EXPONE FRUSTRACION, SEÑALAMIENTOS Y BULLING; COMO POSIBLES DETONANTES DE SU ESTADO EMOCIONAL INESTABLE. MADRE COMENTA QUE ES UN PACIENTE TRANQUILA, SIN ANTECEDENTES DE INESTABILIDAD ANIMICA, NO HA PRESENTADO EPISODIOS DE AUTOAGRESION NI HETEROAGRESION, MANTIENE BUEN RENDIMIENTO ACADEMICO Y BUENA INTERACCION SOCIAL. SIN EMBARGO MANIFIESTA QUE EN LOS ULTIMOS MESES HA PRESENTADO EPISODIOS DE TRISTEZA, DISMINUCION DE LA VOLUNTAD Y EL INTERES, HIPERSOMNIA, QUE REPERCUTE EN SU FUNCIONALIDAD. COMO DATO A EVALUAR Y DE SEGUIMIENTOS REFIERE EPISODIOS DE ALTERACIONES SENSORIOPERCEPTIVAS AUDITIVAS SUGESTIVAS DE ALUCINACIONES AUDITIVAS CON VOZ DE MENSAJE NEGATIVO (DESPECTIVO) PERO NIEGA VOCES COMANDO CON CONTENIDO DE SUICIDIO, LAS CUALES NO ESPECIFICA CON DETALLE EN EL MOMENTO. LA PACIENTE EN EL MOMENTO MANIFIESTA ESTAR MAS TRANQUILA, SIN ANSIEDAD, CON INESTABILIDAD ANIMICA, CON AUTOCRITICA DE LA SITUACION, SIN EMBARGO CON IDEAS RUMIANTES DE MUERTE, AUNQUE NO ESPECIFICA PLANEAMIENTO AUTOLITICO EN EL MOMENTO. NO REFIEREN ANTECEDENTES DE TRATAMIENTOS O EVALUACIONES PREVIAS POR SALUD MENTAL.

A LA VALORACION AMABLE, COLABORADORA, BUENA DISPOSICION AL INTERROGATORIO. CONCIENTE, ORIENTADA GLOBALMENTE, EUPROSEXICA, JUICIO CONSERVADO, CON BUENA CONCIENCIA DE SU SITUACION PERO ESCASA DE ENFERMEDAD. AFECTO DISPLACENTERO, HIPOTIMICA, HIPOBULICA, DISCRETO, ANSIEDAD SIN SIGNOS DE INQUIETUD PSICOMOTRIZ, ANIMO MODULADO CON EPISODIOS DE RISA EN CIERTOS MOMENTOS DEL INTERROGATORIO. PENSAMIENTO DE CURSO NORMAL, CONTENIDO NO DELIRANTE, CON IDEAS RUMIANTES DE MUERTE, SIN PLANEAMIENTO CLARO Y ELABORADO EN EL MOMENTO, IDEAS DE MINUSVALIA. SIN ALTERACION DE LA SENSORIOPERCEPCION (NO DELIRIOS NI ALUCINACIONES). SIN SIGNOS DE AUTO O HETEROAGRESION EN EL MOMENTO, INTROSPECCION REGULAR, PROSPECCION A CONSTRUCCION.

ANALISIS: PACIENTE CON TRASTORNO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS EN EL MOMENTO, IDEAS RUMIANTES DE MUERTE, NIEGA PLANEAMIENTO EN EL MOMENTO. ALTERACION SENSORIOPERCEPTIVA TIPO ALUCINACIONES AUDITIVAS A ESTUDIO. CON RIESGO VITAL MODERADO A ALTO PRESENTA BUENA RED DE APOYO FAMILIAR Y SOCIAL. MANTIENE FUNCIONALIDAD. SE REALIZA MANEJO PRIORITARIO CON EQUIPO DE SALUD MENTAL, MANEJO AMBULATORIO REFORZADO Y PRIORITARIO CON PSIQUIATRIA Y PSICOLOGIA CONSULTA EXTERNA. SE ORDENA ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE POR FAMILIARES, SE DAN RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA PARA NUEVA VALORACION POR URGENCIA PSIQUIATRIA.

PLAN:

MANEJO PRIORITARIO CON EQUIPO DE SALUD MENTAL, MANEJO AMBULATORIO REFORZADO Y PRIORITARIO CON PSIQUIATRIA Y PSICOLOGIA (CONTROL E 8 DIAS) CONSULTA EXTERNA.

SE ORDENA ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE (24 HORAS) POR FAMILIARES EN SU DOMICILIO Y ENTORNO ESTUDIANTIL.

SE DAN RECOMENDACIONES Y PAUTAS DE ALARMA

MEDICACION:

- RISPERIDONA TAB 1MG VO (0-0-1)

- FLUOXETINA JARABE 20MG/5ML VO (INICIALMENTE 2.5ML POR LAS MAÑANAS POR UNA SEMANA Y LUEGO 5ML POR LAS MAÑANAS).

29/11/2025 04:57 p. m. PINEDA ESPITIA NELLYS LEONOR

Revaloracion:
PSIQUIATRIA:
 PACIENTE EN LA UNIDAD CON FAMILIAR PRESENTE (MADRE). INGRESA POR CUADRO CLINICO CARACTERIZADO POR IDEAS DE MUERTE, CON PLANEAMIENTO AUTOLITICO SIN EJECUCION (LANZARSE DE ALTURA EN EL COLEGIO). COMENTA PACIENTE QUE EL DIA JUEVES (27/11/25), EN EL COLEGIO, PRESENTO CONDUCTA IMPULSIVA ACOMPAÑADO DE CRISIS DE ANSIEDAD, CON RIESGO DE LANZAMIENTO DE ALTURA, DEBIDO A SU EPISODIO DE INESTABILIDAD EMOCIONAL. PREVIO A DICHA SITUACION REALIZO NOTAS DE TEXTO MANIFIESTANDO SU TRISTEZA E INESTABILIDAD EMOCIONAL, CON UN MENSAJE AMBIVALENTE DONDE "SE DESPEDIA DE LAS PERSONAS" PERO A LA VEZ COMENTABA LOS PLANES QUE DESEABA A FUTURO. COMENTA PACIENTE ADEMÁS QUE DIAS PREVIOS A RAZ DE FRUSTRACION POR MAL RENDIMIENTO ACADEMICO, COMENZO A MADURAR LAS IDEAS NEGATIVAS DE MUERTE Y PLANEAMIENTO, SIN EMBARGO LA MAGNITUD Y CONSECUENCIAS DEL ACTO A LLEVAR A CABO; LA PUSIERON EN UN CONTEXTO DE NO DESEAR LLEVAR A CABO UN EVENTO AUTOLITICO. MANIFIESTA QUE HA VENIDO CON INESTABILIDAD EN SU ESTADO ANIMICO (NO DESCRIBE UNA CAUSA PUNTUAL) PERO EXPONE FRUSTRACION, SEÑALAMIENTOS Y BULLING; COMO POSIBLE DETONANTES DE SU ESTADO EMOCIONAL INESTABLE. MADRE COMENTA QUE ES UNA PACIENTE TRANQUILA, SIN ANTECEDENTES DE INESTABILIDAD ANIMICA, NO HA PRESENTADO EPISODIOS DE AUTOAGRESION NI HETEROAGRESION, MANTIENE BUEN RENDIMIENTO ACADEMICO Y BUENA INTERACCION SOCIAL. SIN EMBARGO MANIFIESTA QUE EN LOS ULTIMOS MESES HA PRESENTADO EPISODIOS DE TRISTEZA, DISMINUCION DE LA VOLUNTAD Y EL INTERES, HIPERSOMNIA, QUE REPERCUTE EN SU FUNCIONALIDAD. COMO DATO A EVALUAR Y DE SEGUIMIENTOS REFIERE EPISODIOS DE ALTERACIONES SENSORIOPERCEPTIVAS AUDITIVAS SUGESTIVAS DE ALUCINACIONES AUDITIVAS CON VOZ DE MENSAJE NEGATIVO (DESPECTIVO) PERO NIEGA VOCES COMANDO CON CONTENIDO DE SUICIDIO, LAS CUALES NO ESPECIFICA CON DETALLE EN EL MOMENTO. LA PACIENTE EN EL MOMENTO MANIFIESTA ESTAR MAS TRANQUILA, SIN ANSIEDAD, CON INESTABILIDAD ANIMICA, CON AUTOCRITICA DE LA SITUACION, SIN EMBARGO CON IDEAS RUMIANTES DE MUERTE, AUNQUE NO ESPECIFICA PLANEAMIENTO AUTOLITICO EN EL MOMENTO. NO REFIEREN ANTECEDENTES DE TRATAMIENTOS O EVALUACIONES PREVIAS POR SALUD MENTAL. A LA VALORACION AMABLE, COLABORADORA, BUENA DISPOSICION AL INTERROGATORIO. CONCIENTE, ORIENTADA GLOBALMENTE, EUPROSEXICA, JUICIO CONSERVADO, CON BUENA CONCIENCIA DE SU SITUACION PERO ESCASA DE ENFERMEDAD AFECTO DISPLACENTERO, HIPOTIMICA, HIPOBULICA, DISCRETA ANSIEDAD SIN SIGNOS DE INQUIETUD PSICOMOTRIZ, ANIMO MODULADO CON EPISODIOS DE RISA EN CIERTOS MOMENTOS DEL INTERROGATORIO. PENSAMIENTO DE CURSO NORMAL, CONTENIDO NO DELIRANTE, CON IDEAS RUMIANTES DE MUERTE, SIN PLANEAMIENTO CLARO Y ELABORADO EN EL MOMENTO, IDEAS DE MINUSVALIA. SIN ALTERACION DE LA SENSORIOPERCEPCION (NO DELIRIOS NI ALUCINACIONES). SIN SIGNOS DE AUTO O HETEROAGRESION EN EL MOMENTO, INTROSPECCION REGULAR, PROSPECCION A CONSTRUCCION.

ANALISIS: PACIENTE CON TRASTORNO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS EN EL MOMENTO, IDEAS RUMIANTES DE MUERTE, NIEGA PLANEAMIENTO EN EL MOMENTO. ALTERACION SENSORIOPERCEPTIVA TIPO ALUCINACIONES AUDITIVAS A ESTUDIO. CON RIESGO VITAL MODERADO A ALTO, PRESENTA BUENA RED DE APOYO FAMILIAR Y SOCIAL. MANTIENE FUNCIONALIDAD. SE REALIZA MANEJO PRIORITARIO CON EQUIPO DE SALUD MENTAL, MANEJO AMBULATORIO REFORZADO Y PRIORITARIO CON PSIQUIATRIA Y PSICOLOGIA CONSULTA EXTERNA. SE ORDENA ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE POR FAMILIARES, SE DAN RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA PARA NUEVA VALORACION POR URGENCIA PSIQUIATRIA.

PLAN:
 MANEJO PRIORITARIO CON EQUIPO DE SALUD MENTAL, MANEJO AMBULATORIO REFORZADO Y PRIORITARIO CON PSIQUIATRIA Y PSICOLOGIA (CONTROL EN 8 DIAS) CONSULTA EXTERNA.
 SE ORDENA ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE (24 HORAS) POR FAMILIARES EN SU DOMICILIO Y ENTORNO ESTUDIANTIL.
 SE DAN RECOMENDACIONES Y PAUTAS DE ALARMA
 MEDICACION:
 - RISPERIDONA TAB 1MG VO (0-0-1)
 - FLUOXETINA JARABE 20MG/5ML VO (INICIALMENTE 2.5ML POR LAS MAÑANAS POR UNA SEMANA Y LUEGO 5ML POR LAS MAÑANAS).

SERVICIOS		
CÓDIGO	NOMBRE	HC
890308	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR PSICOLOGIA	☒
890484	INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA	☒
MEDICAMENTOS		
CÓDIGO	NOMBRE	HC
MD0381	RISPERIDONA 1 MG TAB	☒
MD0589	FLUOXETINA 20 MG/ 5 ML SOL ORAL	☒

INDICACIÓN MEDICA
REVALORACIÓN DE OBSERVACION

N° Historia Clínica: 1066292466

N° Folio:

17

Folio Asociado:

DATOS PERSONALES

Nombre Paciente: GUADALUPE PERALTA SABALLET

Identificación: 1066292466

Sexo: Femenino

Fecha Nacimiento: 14/enero/2014 Edad Actual: 11 Años / 10 Meses / 14 Días

Estado Civil: Soltero

Dirección: CALLE 9B 22 94 IRACAL

Teléfono: 3104597821

Procedencia: VALLEDUPAR

Ocupación:

DATOS DE AFILIACIÓN

Entidad: SALUD TOTAL EPS-S - PG HOSPITALARIO

Régimen: Regimen_Simplificado

Plan Beneficios: SALUD TOTAL EPS-S REGIMEN CONTRIBUTIVO (PG)

Nivel - Estrato: CONTRIBUTIVO RANGO A

DATOS DEL INGRESO

Responsable: MARGARET ZABALLET BORJA

Teléfono Resp: 3104597821

Dirección Resp: CALLE 9B 22 94 IRACAL

N° Ingreso: 352050 Fecha: 29/11/2025 10:49:18 a. m.

Finalidad Consulta: Diagnostico

Causa Externa: Enfermedad_general

INDICACIÓN MEDICA

Tipo Indicación: Salida

Detalle:

PLAN:

MANEJO PRIORITARIO CON EQUIPO DE SALUD MENTAL, MANEJO AMBULATORIO REFORZADO Y PRIORITARIO CON PSIQUIATRIA Y PSICOLOGIA (CONTROL EN 8 DIAS) CONSULTA EXTERNA.

SE ORDENA ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE (24 HORAS) POR FAMILIARES EN SU DOMICILIO Y ENTORNO ESTUDIANTIL.

SE DAN RECOMENDACIONES Y PAUTAS DE ALARMA

MEDICACION:

- RISPERIDONA TAB 1MG VO (0-0-1)

- FLUOXETINA JARABE 20MG/5ML VO (INICIALMENTE 2.5ML POR LAS MAÑANAS POR UNA SEMANA Y LUEGO 5ML POR LAS MAÑANAS).

PLAN DE MANEJO EXTERNO
REVALORACIÓN DE OBSERVACION

Nº Historia Clínica: 1066292466

Nº Folio: 17

Folio Asociado:

DATOS PERSONALES

Nombre Paciente: GUADALUPE PERALTA SABALLET

Identificación: 1066292466

Sexo: Femenino

Fecha Nacimiento: 14/enero/2014 Edad Actual: 11 Años / 10 Mses / 14 Días

Estado Civil: Soltero

Dirección: CALLE 9B 22 94 IRACAL

Teléfono: 3104597821

Procedencia: VALLEDUPAR

Ocupación:

DATOS DE AFILIACIÓN

Entidad:

Régimen: Regimen_Simplificado

Plan Beneficios: EPSC02 - SALUD TOTAL EPS-S REGIMEN CONTRIBUTIVO Nivel - Estrato: CONTRIBUTIVO RANGO A (PG)

DATOS DEL INGRESO

Responsable: MARGARET ZABALLET BORJA

Teléfono Resp: 3104597821

Dirección Resp: CALLE 9B 22 94 IRACAL

Nº Ingreso: 352050 Fecha: 29/11/2025 10:49:18 a. m.

Finalidad Consulta: Diagnostico

Causa Externa: Enfermedad_general

Area Servicios OBSERVACION PEDIATRICA

INDICACIONES A PACIENTE

Indicación: SE ORDENA ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE (24 HORAS) POR FAMILIARES EN SU DOMICILIO Y ENTORNO ESTUDIANTIL.

Total Ítems: 1

Nellys Pineda E
1140887548

Firmada electrónicamente por NELLYS LEONOR PINEDA ESPITIA
Registro Médico: 1140887548 Especialidad Médica: MEDICINA GENERAL

Vigencia de la Prescripción 30 días

PLAN DE MANEJO EXTERNO SERVICIOS

REVALORACIÓN DE OBSERVACION

N° Historia Clínica: 1066292466

N° Folio:

17

Folio Asociado:

DATOS PERSONALES

Nombre Paciente: GUADALUPE PERALTA SABALLET

Identificación: 1066292466

Sexo: Femenino

Fecha Nacimiento: 14/enero/2014 Edad Actual: 11 Años / 10 Meses / 14 Días

Estado Civil: Soltero

Dirección: CALLE 9B 22 94 IRACAL

Teléfono: 3104597821

Procedencia: VALLEDUPAR

Ocupación:

DATOS DE AFILIACIÓN

Entidad: SALUD TOTAL EPS-S - PG HOSPITALARIO

Régimen: Regimen_Simplificado

Plan Beneficios: SALUD TOTAL EPS-S REGIMEN CONTRIBUTIVO (PG)

Nivel - Estrato: CONTRIBUTIVO RANGO A

DATOS DEL INGRESO

Responsable: MARGARET ZABALLET BORJA

Teléfono Resp: 3104597821

Dirección Resp: CALLE 9B 22 94 IRACAL

N° Ingreso: 352050 Fecha: 29/11/2025 10:49:18 a. m.

Finalidad Consulta: Diagnostico

Causa Externa: Enfermedad_general

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS NO QX		AREA SERVICIO: 06	CONSULTA EXTERNA	
CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	ESTADO
890308	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR PSICOLOGIA		1	Rutinario
Observaciones:	EN 8 DIAS POR SU EPS			
890484	INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA		1	Rutinario
Observaciones:	(CONTROL EN 8 DIAS) CONSULTA EXTERNA.			
			Total Ítems:	2

PLAN DE MANEJO EXTERNO
REVALORACIÓN DE OBSERVACION

N° Historia Clínica: 1066292466

N° Folio: 17

Folio Asociado:

DATOS PERSONALES

Nombre Paciente: GUADALUPE PERALTA SABALLET

Identificación: 1066292466

Sexo: Femenino

Fecha Nacimiento: 14/enero/2014 Edad Actual: 11 Años / 10 Meses / 14 Días

Estado Civil: Soltero

Dirección: CALLE 9B 22 94 IRACAL

Teléfono: 3104597821

Procedencia: VALLEDUPAR

Ocupación:

DATOS DE AFILIACIÓN

Entidad:

Régimen: Regimen_Simplificado

Plan Beneficios: EPSC02 - SALUD TOTAL EPS-S REGIMEN CONTRIBUTIVO Nivel - Estrato: CONTRIBUTIVO RANGO A (PG)

DATOS DEL INGRESO

Responsable: MARGARET ZABALLET BORJA

Teléfono Resp: 3104597821

Dirección Resp: CALLE 9B 22 94 IRACAL

N° Ingreso: 352050 Fecha: 29/11/2025 10:49:18 a. m.

Finalidad Consulta: Diagnostico

Causa Externa: Enfermedad_general

Area Servicios OBSERVACION PEDIATRICA

MEDICAMENTOS POS

Medic MD038RISPERIDONA 1 MG TAB

Valor Dispensado OPL \$ 0,00

Cantidad: 60

SESE

ament 1

NTA

o:

Concentracion: 1 MG

UnidadMILIGRAMO

Via Administracion:

Oral

Duracion 60

Horas Vigencia: 24

Observaciones: - RISPERIDONA TAB IMG VO (0-0-1): TOMAR 1 TAB POR LAS NOCHES POR 60 DIAS

Medic MD058FLUOXETINA 20 MG/ 5 ML SOL ORAL

Valor Dispensado OPL \$ 0,00

Cantidad: 1

UN

ament 9

o:

Concentracion: 20MG/60ML

UnidadMILIGRAMO

Via Administracion:

Oral

Duracion 1

Horas Vigencia: 24

Observaciones: - FLUOXETINA JARABE 20MG/5ML VO (INICIALMENTE 2.5ML POR LAS MAÑANAS POR UNA SEMANA Y LUEGO 5ML POR LAS MAÑANAS).

Total Items: 2

Nellys Pineda E
1140887548

Firmada electrónicamente por NELLYS LEONOR PINEDA ESPITIA

Vigencia de la Prescripción 30 días

Registro Médico: 1140887548 Especialidad Médica: MEDICINA GENERAL